

1. La brûlure :

- A. Est définie par la destruction totale du revêtement cutané et sous cutané
- B. Est thermique si elle est due à un agent solvant de haute température
- C. Est de cicatrisation in situ quand si elle est évaluée de 2^{ème} degré au maximum
- D. Est dite définie par le terme quand elle atteint les structures osseuses
- E. Est de mauvais pronostic chez l'enfant si le score de Baux dépasse est >75

2. Sur le plan histologique, dans une brûlure de second degré profond :

- A. Est une destruction partielle de la membrane basale
- B. Est caractérisée par l'atteinte dermique avec un épiderme intact
- C. Est caractérisée par une cicatrisation spontanée centripète
- D. La cicatrisation ad integrum est possible en 21 jours
- E. La cicatrisation spontanée est souvent aléatoire

3. Sur le plan physiopathologique, chez les victimes de brûlures cutanées :

- A. Il y a une sécrétion abondante des médiateurs d'inflammation à partir de J3
- B. Il y a une hyperperméabilité capillaire en zone brûlée et non brûlée
- C. Il y a une hypoprotidémie par fuite vasculaire dès les premières minutes
- D. Il y a une augmentation de la pression hydrostatique extra capillaire
- E. Il y a une augmentation de la pression oncotique plasmatique

4. La brûlure 2ème degré superficielle :

- A. Ne touche que la couche épidermique
- B. Est de couleur blanc nacré
- C. Est caractérisée par l'apparition de phlyctènes
- D. La guérison est obtenue en 3 à 4 jours
- E. La cicatrisation se fait du centre à la périphérie

5. La brûlure de 2ème degré profond :

- A. Est exceptionnellement douloureuse
- B. Est caractérisée par une couleur rose pâle de la peau
- C. Se cicatrise en une 3 semaine de manière centrifuge
- D. Est caractérisée par une atteinte partielle de la membrane basale
- E. Se cicatrise aléatoirement avec des rétractions cutanées étendues

6. Parmi les propositions suivantes concernant les brûlures une ou plusieurs sont correctes :

- A. Les brûlures 2ème degré superficiel induisent une atteinte de l'épiderme et de la membrane basale.
- B. La brûlure 3ème degré est indolore avec une couleur blanc nacré
- C. Leur topographie est stable durant les premières 48 heures
- D. Les brûlures 2ème degré profond ou brûlure intermédiaire ont un aspect blanc décoloré.
- E. Un placard cartonné est caractéristique des brûlures de 2ème degré profond

7. En cas de brûlures cutanées :

- A. la réaction inflammatoire systémique est caractérisée par la sécrétion d'interleukines
- B. Le choc hypovolémique caractérise les premières heures
- C. il y a une hypercoagulabilité précoce, suivie d'une phase d'hypocoagulabilité
- D. Il y a un hypercatabolisme musculaire avec un risque de dénutrition
- E. L'hyperalgésie secondaire est induite par compression cutanée tardive

8. En cas de brulures cutanées avec inhalation de fumées toxiques :

- A. Le traitement doit inclure l'oxygène hyperbare
- B. Il est possible que le patient soit dysphonique
- C. Une acidose métabolique minérale est fréquente
- D. L'effet le plus grave est l'effet local irritant
- E. Il est possible d'objectiver des brulures muqueuses pulmonaires

9. Les brulures cutanées sont évaluées graves si :

- A. L'indice UBS est supérieur à 20%
- B. Le score de BAUX est supérieur à 50
- C. La brulure est associée à un traumatisme grave
- D. L'âge est supérieur à 60 ans
- E. La surface cutanée de brulure profonde est > 10%

10. En cas de brulures cutanées, les facteurs associés à une haute mortalité sont :

- A. Une SCB > 10%.
- B. L'âge de plus que 60 ans.
- C. L'inhalation de monoxyde de carbone.
- D. Un score UBS supérieur à 100.
- E. Une brûlure thermique de 5%.

11. Concernant l'indice de Baux, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A. Il inclut la surface cutanée brûlée de 3ème degré
- B. Il est applicable à partir de 18 ans
- C. Il se base sur l'âge et la SCB de 3ème degré
- D. Il permet d'estimer la quantité de remplissage nécessaire
- E. Il est corrélé à un très haut risque de mortalité s'il est > 100

12. Concernant l'indice UBS, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s):

- A. Une brulure est dite très grave à partir d'un score 150
- B. Une brulure est dite grave à partir d'un score 50
- C. Une brulure est dite gravissime à partir d'un score 250
- D. Son calcul se base sur la SCB et l'âge
- E. Il inclut les zones brûlées de 3ème degré

13. Concernant les brulures électriques, quelle(s) est (sont) la (les) bonne (s) proposition (s)

- A. Les électrisations de bas voltage sont les plus pourvoyeuses de brulures
- B. Les électrisations par haut voltage provoquent des brulures superficielles
- C. Elles sont caractérisées par leur aspect non évolutif les premières 24 heures
- D. Les lésions sont souvent limitées aux points d'entrée et de sortie
- E. Des brulures par effet joules sont toujours à suspecter

14. Concernant les brulures chimiques, quelle(s) est (sont) la (les) bonne (s) proposition (s)

- A. Comme les brulures électriques, les lésions sont souvent évolutives
- B. Les lésions cutanées sont souvent limitées
- C. Elles sont accompagnées de lésions vasculaires constantes
- D. Elles peuvent être accompagnées d'intoxication générale
- E. Elles sont caractérisées par les portes d'entrée et de sortie du produit

15. L'atteinte respiratoire au cours des brulures thermiques peut être expliquée par:

- A. La myocardite toxique
- B. La brulure alvéolaire
- C. L'hyperproduction de surfactant
- D. La hausse de l'élastance pulmonaire
- E. La baisse de la compliance thoracique

16. Au cours des brulures :

- A. La réponse inflammatoire est cellulaire et humorale
- B. Il y a un afflux massif de monocytes dans la zone brûlée
- C. L'hyperactivité cellulaire induit une activation de la fonction immunitaire
- D. Les tissus brûlés libèrent des médiateurs pro et anti inflammatoires
- E. La production d'IL6 se prolonge durant plusieurs semaines

17. La défaillance hémodynamique observée les premières heures de brulure peut être secondaire à :

- A. L'hyperperméabilité capillaire (en zone brûlée et non brûlée)
- B. L'hypovolémie secondaire à la plasmorragie
- C. L'hémoconcentration induite par la fuite cellulaire
- D. L'atteinte cardiaque directe par les fumées toxiques
- E. L'ischémie coronaire par les médiateurs inflammatoires

18. L'état de choc observé à la phase initiale chez un patient brûlé est caractérisé par :

- A. Des pressions de remplissage des cavités cardiaques diminuées
- B. Un index cardiaque élevé
- C. Des résistances vasculaires systémiques indexées élevées
- D. Une saturation veineuse centrale en oxygène >65%
- E. Des résistances vasculaires systémiques supérieures à 800 dyn/cm²

19. Chez les brûlés, une insuffisance rénale aiguë est possible

- A. Quand il y a un syndrome compartimental abdominal
- B. Par myoglobinurie, très fréquente dans les brulures radicales
- C. Par nécrose tubulaire aiguë en cas d'inhalation de monoxyde de carbone
- D. Par insuffisance d'alcalinisation précoce
- E. Quand l'hypovolémie n'est pas gérée rapidement

20. Le syndrome compartimental abdominal (SCA) chez un brûlé grave :

- A. Induit une hausse de l'élastance pulmonaire.
- B. Induit une baisse de la compliance thoracique.
- C. Peut indiquer une aponévrotomie de décharge.
- D. Induit la translocation bactérienne.
- E. Peut être secondaire au remplissage vasculaire massif

21. En cas de brulures récentes, certaines mesures thérapeutiques sont envisagées: (choisir la ou les réponses exactes)

- A. Les soins des brulures peuvent être reportés après la gestion des lésions traumatiques graves
- B. L'oxygénothérapie normobare est systématique en cas d'intoxication de fumées
- C. Le remplissage vasculaire est débuté à la phase hyperkinétique du choc
- D. L'intubation est imposée en cas de brulures circulaires du cou
- E. L'apport liquidien est majoré à partir de H48 de réanimation

22. La prise en charge thérapeutique initiale des patients brûlés doit comprendre : (choisir la ou les réponses exactes)

- A. Un refroidissement extensif de tout le corps
- B. L'administration systématique d'oxygène hyperbare
- C. Un remplissage vasculaire estimé selon la formule de Baux
- D. Une analgésie efficace à partir de H72
- E. Une antibiothérapie empirique dès la phase hyperkinétique du choc

23. La prise en charge thérapeutique initiale des patients brûlés doit comprendre : (choisir la ou les réponses exactes)

- A. Un remplissage vasculaire guidé par le monitoring hémodynamique invasif
- B. Un remplissage vasculaire guidé par les formules d'estimation de la quantité
- C. Un remplissage par des colloïdes pour augmenter la pression oncotique
- D. L'apport d'albumine après H6 si la SCB est > à 30% et l'albumine < 30g/l
- E. Une alcalinisation si le mécanisme est une brûlure électrique

24. La prise en charge thérapeutique initiale des patients brûlés consiste en: (choisir la ou les réponses exactes)

- A. Une réanimation volémique selon la formule de Carvajal chez les enfants
- B. Un bolus de 20ml/kg de ringer lactate à H6 si la SCB est > 10%
- C. Une réanimation volémique selon la SCB en cas de brûlures électriques
- D. Une majoration des besoins de 40% chez les enfants de moins de 6 ans
- E. Un apport de sérum glucosé si on utilise la formule de Baxter

Cas clinique**25. Patient âgé de 35 ans (poids 70Kg) victime d'une brûlure thermique (feu), au niveau de la face antérieure du tronc, face antérieure du membre inférieur droit de 3ème degré, et de la face et cou de 2ème degré**

- A. La surface cutanée brûlée chez ce patient est estimée aux alentours de 30%
- B. Le score de Baux est de 66,5
- C. L'UBS est de 50
- D. La réanimation volémique a pour objectif une diurèse de 0,5 cc/Kg/h
- E. L'intubation trachéale est nécessaire dès la première heure

26. Chez ce patient, la réanimation volémique doit comporter

- A. Un bolus de 1400ml de ringer lactate la première heure
- B. 8l de liquide en 8 heures
- C. 5800 ml sur 16heures, à la fin de H8
- D. Une surveillance horaire de la diurèse maintenue à 0,5ml/kg/h
- E. Le recours au cyanokit vu la brûlure faciale

27. Chez ce patient, le traitement local des zones brûlées comportera

- A. Une aponévrotomie de décharge des lésions du membre inférieur brûlé
- B. La détersion assistée des lésions faciales
- C. Une greffe cutanée sera certaine au niveau de la face
- D. L'épidermisation sera substituée par une greffe cutanée au niveau du tronc
- E. Une excision chirurgicale pour les lésions de 2ème degré superficiel

Cas clinique

- Une femme âgée de 28 ans, est admise en urgence pour brûlure au feu à la suite d'un accident domestique (foyer de feu au rideau).
- L'examen initial a montré une patiente consciente, un score de Glasgow 15/15, FC à 118 b/min, PA 121/69 mmHg. Elle a une FR de 24c/min, SpO2 98% AA.
- On note des brûlures du 2ème degré au niveau de la face postérieure du membre supérieur gauche et de la face postérieure du thorax.

28. Pour estimer la surface corporelle brûlée, on peut utiliser :

- A. La règle des 9 de Wallace.
- B. Le score ABSI.
- C. Le score de Baux.
- D. Le score UBS.
- E. La table de Lund et Browder

29. Chez cette patiente la surface cutanée brûlée est estimée à :

- A. 9%
- B. 13%
- C. 18%
- D. 22%
- E. 32%

30. Concernant la prise en charge initiale, la(les) quelle(s) de ces propositions est(sont) exacte(s) :

- A. La perfusion de 10 ml.kg⁻¹ de cristalloïdes à administrer au cours de la première heure.
- B. L'administration de 2 ml.kg⁻¹ au cours des 8 premières heures selon la formule de Parkland.
- C. En cas d'inhalation de fumée associée, les besoins doivent être majorés de 30 à 50%
- D. La diurèse horaire ne doit pas dépasser le 0.5 ml/kg
- E. Les antibiotiques sont recommandés à H72 de réanimation